HagaZiekenhuis

Nazorg genezing lieswond na hartkatheterisatie of dotter-/stentbehandeling

In deze folder vindt u informatie over de genezing van een lieswond na een hartkatheterisatie of een dotter-/stentbehandeling via uw liesslagader. Om complicaties (zoals een bloeding) te voorkomen, is het belangrijk dat de wond in de lies snel herstelt. Daarom vindt u in deze folder enkele aandachtspunten en adviezen voor de nazorg.

Bedrust

De arts heeft de liesslagader na afloop van de ingreep dichtgemaakt met een afsluitsponsje of een clipje. De wond is verbonden met een drukverband, dat tot minimaal een uur na de ingreep moet blijven zitten.

De eerste uren na de ingreep moet u plat in bed blijven liggen. Hoelang deze bedrust moet zijn, is afhankelijk van welk soort afsluitsysteem is gebruikt en welke bloedverdunners u krijgt. Na de ingreep vertelt uw arts of verpleegkundige hoe lang de bedrust voor u duurt.

Bij bedrust gelden de volgende aandachtspunten:

- Het hoofdeinde van het bed staat in een positie van maximaal 30 graden.
- Tijdens hoesten, niezen en persen moet u tegendruk geven: dit doet u door uw hand op het verband van de lies te drukken.

Bloeduitstorting

Het kan zijn dat er een bloeduitstorting op de aanprikplaats in de lies ontstaat. Deze bloeduitstorting kan ook naar beneden zakken. De kleur zal langzaam veranderen en na ongeveer zes weken is het vaak verdwenen. Als de bloeduitstorting pijn veroorzaakt en/of ineens dik wordt, geeft u dit direct door aan de verpleegkundige. Dit kan een teken zijn dat de wond nog vocht afgeeft.

Actieve bloeding

U waarschuwt direct een verpleegkundige (of belt thuis 112) als u:

- een warm gevoel in de lies krijgt.
- (heftige) pijn in been, lies, buik en/of rug heeft.
- een snel groeiende zwelling in de lies bemerkt.
- licht in uw hoofd bent.
- niet lekker wordt.
- de wond met krachtige, snelle stoten gaat bloeden.

Bij deze klachten kan sprake zijn van een actieve bloeding. Als dit gebeurt als u thuis bent, moet u direct het alarmnummer 112 (laten) bellen.

Leefregels na ontslag

- Probeer de dag na de ingreep zo weinig mogelijk te lopen. Kleine stukjes in en om het huis zijn geen probleem, maar vermijd lange(re) afstanden.
- Beperk het traplopen zoveel mogelijk de dag na de ingreep. Moet u een trap oplopen, doet u dit dan rustig, tree voor tree.
- Als u een geplande ingreep hebt ondergaan, mag u de eerste 72 uur na de ingreep niet fietsen of autorijden. Regelt u vooraf iemand die u naar huis kan begeleiden. Als dit niet mogelijk is, kan er een taxi voor u worden gebeld. Wilt u dit vooraf aangeven?
- Als u vanwege een hartinfarct bent opgenomen, mag u de eerste 4 weken geen auto besturen. Dit is in de wet bepaald.
- 24 uur na de ingreep mag u weer douchen. Ten minste de eerste vijf dagen mag u niet in bad en ook niet gaan zwemmen. Als de wond na vijf dagen nog niet dicht is, moet u hiermee langer wachten.
- Als u een wondpleister heeft, kunt u deze de dag na de ingreep zelf verwijderen. Maak het wondje voorzichtig schoon met wat water en liefst geen zeep. Als het wondje nog niet helemaal dicht is, kunt u er een droge pleister op doen. Als het wondje dicht is, hoeft er geen pleister meer op.
- Pas uw activiteiten de eerste 48 tot 72 uur na de ingreep aan. Om de slagader goed te laten genezen, is het belangrijk dat u niet teveel druk uitoefent op de slagader. Dit betekent:
  - niet persen
  - niet zwaarder dan 5 kilo tillen
- Bij bepaalde afsluitsystemen, zoals een Angioseal, krijgt u een kaartje mee, dat u drie maanden bij u moet dragen. Dit kaartje moet u bij een eventuele volgende ingreep laten zien.
- Beperk strak zittende kleding of ondergoed. De plek in de lies waar u bent behandeld, kan hierdoor geïrriteerd raken voordat deze goed hersteld is. Draag gemakkelijk zittende kleding.
- Als het geen grote belasting is voor uw lies, kunt u uw dagelijkse lichte bezigheden en activiteiten drie dagen na de ingreep hervatten.
- Overleg met uw arts wanneer u kunt beginnen met sporten en met zwaardere lichamelijke arbeid. Vaak is dit twee weken na ontslag weer mogelijk.

Bloedverdunners

Wanneer u een stent heeft gekregen, is er een verhoogde kans dat er een bloedprop in de stent ontstaat. Om dit te voorkomen slikt u **tegelijk 2 soorten bloedverdunners:**

1. Ascal, Acetylsalicylzuur of Carbasalaatcalcium
2. Clopidogrel, Ticagrelor of Prasugrel (ook wel: Plavix, Grepid, Brilique of Efient).

Sommige mensen moeten zelfs tijdelijk 3 soorten bloedverdunners gebruiken. Dat komt doordat een bloedprop in een stent dodelijk kan zijn. Het is belangrijk dat u de medicijnen volgens de gemaakte afspraken met uw arts inneemt. Een tot een paar dagen onderbreken of vergeten kan al een bloedprop veroorzaken.

Contact met het HagaZiekenhuis

Neem direct contact op met het HagaZiekenhuis als:

- u een bloeding heeft uit het wondje van de lies
- er sprake is van een toenemende zwelling in de lies of het been
- er gevoelloosheid of pijn in het been optreedt
- er huiduitslag ontstaat
- u koorts heeft (hoger dan 38
- u wondvocht verliest

Hoe neemt u contact op?

- van 8.00 – 16.00 uur met de Cardiolounge via telefoonnummer (070) 210 3119
- van 16.00 – 8.00 uur en in het weekend met de verpleegafdeling Cardiologie via telefoonnummer (070) 210 2805

Acuut niet lekker?

Voelt u zich acuut en ernstig niet lekker worden, dan kunt u het alarmnummer 112 (laten) bellen. Ook als de wond in de lies met krachtige, snelle stoten gaat bloeden, moet u direct het alarmnummer 112 bellen. Er is dan sprake van een slagaderlijke bloeding en u heeft snel medische hulp nodig. Probeer de wond met twee vingers af te drukken.

Vragen

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met het secretariaat, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 11.00 uur via telefoonnummer (070) 210 2305. Voor vragen over het verblijf op de Cardiolounge belt u op kantoordagen tussen 8.00 en 16.00 uur telefoonnummer (070) 210 3119. U kunt ook uw vragen noteren en bij opname meenemen naar het ziekenhuis.

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228. Dank u wel.

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this brochure with someone who can translate or explain the information to you.

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

108026022024